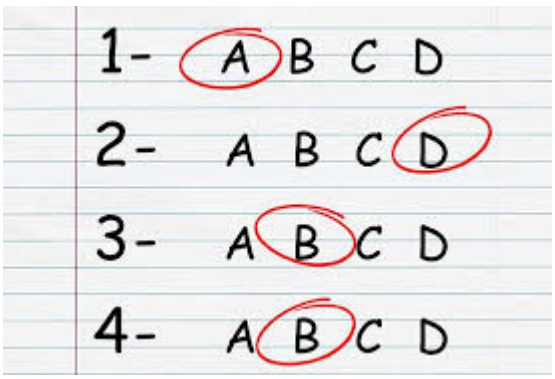


TEMA 45



TEST DEL TEMA

LAS PERSONAS MAYORES.

COMPETENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIALES DEL ENVEJECIMIENTO.

NUEVOS ROLES DE LA PERSONA MAYOR.

POLÍTICAS DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SOLEDAD NO DESEADA.

1.- Para el período 2.021-2.023, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha:

a.- El I Plan de Acción "Madrid, Ciudad Amigable con las personas mayores".

b.- El II Plan de Acción "Madrid, Ciudad Amigable con las personas mayores".

c.- El III Plan de Acción "Madrid, Ciudad Amigable con las personas mayores".

2.- La Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las personas mayores es una iniciativa que parte:

a.- De la UNESCO.

b.- De la OMS.

c.- De la Unión Europea.

3.- En el año 2.002 en Madrid se celebra la Segunda Asamblea de Naciones Unidas sobre Envejecimiento, donde se plantea como elemento central:

a.- El envejecimiento activo.

b.- La prevención de la soledad no deseada.

c.- La prevención del edadismo.

4.- El proyecto de Ciudades Amigables se basa en el concepto de:

a.- Envejecimiento integral.

b.- Envejecimiento participativo.

c.- Envejecimiento activo.

5.- ¿En qué artículo del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid se garantiza la a promoción y ayuda a la tercera edad?:

a.- En el artículo 26.1.22.

b.- En el artículo 26.1.23.

c.- En el artículo 26.1.24.

6.- La Década del Envejecimiento Saludable se ha marcado para el período:

a.- 2.011-2.020.

b.- 2.016-2.021.

c.- 2.021-2.030.

7.- Una ciudad amigable con las personas mayores es una ciudad:

a.- Accesible, transparente y ergonómica.

b.- Versátil, flexible y resistente.

c.- Versátil, flexible y resiliente.

8.- Una ciudad amigable con las personas mayores tendrá especialmente en cuenta:

a.- La variable de género.

b.- La variable económica.

c.- Ambas opciones son correctas.

9.- ¿En qué año se incorporó Madrid a la Red Mundial de Ciudades Amigables con las personas mayores?:

a.- En el año 2.004.

b.- En el año 2.014.

c.- En el año 2.019.

10.- Según los datos del Plan de Acción Madrid Ciudad Amigable con las Personas Mayores, 2.021-2.023, ¿Qué porcentaje hay de población de 65 años o más?:

a.- El 20,06%.

b.- 24, 06%.

c.- El 28,06%.

11.- A partir de los 65 años, cuál es la proporción entre mujeres y hombres?:

a.- 155,4 mujeres por cada 100 hombres.

b.- 135, 4 mujeres por cada 100 hombres.

c.- 98,5 mujeres por cada 100 hombres.

12.- Cual de los siguientes distritos tiene una media de población mayor de 65 años por debajo de la media de la ciudad:

a.- Moratalaz.

b.- Retiro.

c.- Centro.

13.- Entendemos por "cuarta edad":

a.- La población de 85 años o más.

b.- La población de 80 años o más.

c.- La población de 75 años o más.

14.- Según los datos del Plan de Acción Madrid Ciudad Amigable con las Personas Mayores, 2.021-2.023, en Madrid, la cuarta edad:

a.- Representa el 7,1% de la población madrileña.

b.- El 65,7% de la población perteneciente a la cuarta edad son mujeres.

c.- Ambas opciones son correctas.

15.- Dentro del Plan de Acción Madrid Ciudad Amigable con las Personas Mayores, 2.021-2.023, cual de los siguientes ámbitos estratégicos no queda recogido:

a.- Entorno cívico y social.

b.- Prevención y atención integral.

c.- Entorno doméstico saludable.

16.- Los tres ámbitos estratégicos del Plan de Acción Madrid Ciudad Amigable con las Personas Mayores, 2.021-2.023 incorporan como enfoques transversales (señala la opción incorrecta):

a.- Homogeneidad.

b.- Igualdad de género.

c.- Equidad.

17.- La longevidad exige:

a.- Cambios económicos y sociales, pero no cambios políticos.

b.- Proyectos de vida personal y comunitarios distintos.

c.- Ambas opciones son correctas.

18.- El Eje 1 del Plan de Acción Madrid Ciudad Amigable con las Personas Mayores, 2.021-2.023 responde al ámbito estratégico de:

a.- Entorno cívico y social: una ciudad para todas las generaciones.

b.- Prevención y atención integral: una ciudad que responde a las necesidades de la población mayor.

c.- Entorno urbano amigable: una ciudad que se adapta a todas las personas.

19.- El Eje 2 del Plan de Acción Madrid Ciudad Amigable con las Personas Mayores, 2.021-2.023 responde al ámbito estratégico de:

a.- Entorno cívico y social: una ciudad para todas las generaciones.

b.- Prevención y atención integral: una ciudad que responde a las necesidades de la población mayor.

c.- Entorno urbano amigable: una ciudad que se adapta a todas las personas.

20.- El Eje 3 del Plan de Acción Madrid Ciudad Amigable con las Personas Mayores, 2.021-2.023 responde al ámbito estratégico de:

a.- Entorno cívico y social: una ciudad para todas las generaciones.

b.- Prevención y atención integral: una ciudad que responde a las necesidades de la población mayor.

c.- Entorno urbano amigable: una ciudad que se adapta a todas las personas.

21.- Señala cuál de los siguientes objetivos específicos no está recogido en el ámbito estratégico 1 -Una ciudad para todas las generaciones- del Plan de Acción Madrid Ciudad Amigable con las Personas Mayores, 2.021-2.023:

a.- Mejorar los servicios domiciliarios de comidas, lavandería y préstamo de productos de apoyo para adaptarlos a las necesidades de las personas.

b.- Luchar contra la LGTBIfobia y sensibilizar sobre la situación del colectivo de personas mayores LGTBI.

c.- Impulsar la actividad y el ejercicio físico como parte de la estrategia de envejecimiento activo y saludable.

22.- El ámbito estratégico 2 –"Una ciudad que responde a las necesidades de la población mayor"- del Plan de Acción Madrid Ciudad Amigable con las Personas Mayores, 2.021-2.023, se centra especialmente en:

a.- El problema de la soledad no deseada.

b.- Las consecuencias de la pandemia en la población mayor.

c.- La prevención de la dependencia.

23.- Entre las medidas propuestas por el Ayuntamiento para cumplir los objetivos en el ámbito estratégico 2, no se plantean:

a.- Servicios de atención domiciliaria.

b.- Servicios de residencias.

c.- Servicios de centros de día.

24.- Podemos afirmar que la soledad no deseada:

a.- Es causa de la aparición o agravamiento de la dependencia en personas mayores.

b.- Es efecto de la aparición o agravamiento de la dependencia en personas mayores.

c.- Ambas opciones son correctas.

25.- Dentro del ámbito estratégico 3 -Entorno urbano amigable- del Plan de Acción Madrid Ciudad Amigable con las Personas Mayores, 2.021-2.023 encontramos como objetivos específicos:

a.- Avanzar en el conocimiento de alternativas residenciales para personas mayores mediante el estudio y la puesta en marcha de proyectos piloto.

b.- Favorecer el acceso de las personas mayores a las viviendas gestionadas por el Ayuntamiento.

c.- Ambas opciones son correctas.

26.- Dentro del actual Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, las competencias con las personas mayores son asumidas desde:

a.- La Dirección General de Mayores.

b.- La Dirección General de Mayores y Prevención de la Dependencia.

c.- La Dirección General de Mayores y Prevención de la Soledad no Deseada.

27.- Es competencia de la Dirección General de Mayores y Prevención de la Soledad no Deseada, coordinar la intervención de los servicios municipales con aquellas personas mayores que puedan encontrarse (señala la opción incorrecta):

a.- En situación de riesgo.

b.- En situación de maltrato y vulnerabilidad social.

c.- En situación de enfermedad degenerativa.

28.- Los programas y servicios municipales con personas mayores se centran especialmente en:

a.- El mantenimiento de la persona mayor en su propio hogar.

b.- Al apoyo a las familias que cuidan de las personas mayores en su propio hogar.

c.- Ambas opciones son correctas.

29.- Son alternativas habitacionales para las personas mayores (señala la opción incorrecta):

a.- Las viviendas tuteladas.

b.- Las viviendas colaborativas.

c.- Las viviendas compartidas.

30.- Según se recoge en el Plan de Acción Madrid Ciudad Amigable con las Personas Mayores, 2.021-2.023 en los Centros de Día para mayores se avanzará en la implantación de:

a.- Un modelo de atención integral centrada en la persona.

b.- Un modelo de atención integral centrada en la familia.

c.- Un modelo de atención integral centrada en la comunidad.

31.- El Plan de Acción Madrid Ciudad Amigable con las Personas Mayores, 2.021-2.023 se propone que las personas mayores participen activamente en la comunidad por medio del asociacionismo y el voluntariado con un enfoque:

a.- Generacional, solidario y no asistencialista.

b.- Intergeneracional, solidario y no asistencialista.

c.- Intergeneracional, solidario y asistencialista.

32.- El enfoque transversal del Plan de Acción Madrid Ciudad Amigable con las Personas Mayores, 2.021-2.023 hace referencia a la equidad:

a.- Para abordar las desigualdades entre distritos y barrios.

b.- Para abordar las desigualdades entre vecinos.

c.- Para abordar las desigualdades entre los equipamientos de los distritos.

33.- El artículo 50 de la Constitución Española promueve la suficiencia económica de las personas mayores, principalmente mediante:

a.- Un sistema de pensiones.

b.- Un sistema sociosanitario.

c.- Un sistema de servicios sociales.

34.- El sistema de servicios sociales que propone el artículo 50 de la Constitución integra la atención:

a.- A los problemas de salud y de vivienda.

b.- A los problemas de cultura y de ocio.

c.- Ambas opciones son correctas.

35.- Entre las teorías que explican el envejecimiento como una realidad física, podemos destacar (señala la opción incorrecta):

a.- La teoría autoinmune.

b.- La teoría transgénica.

c.- La teoría del desgaste de órganos y tejidos.

36.- El hecho más significativo en los cambios físicos producidos por el envejecimiento, es:

a.- La inevitabilidad.

b.- El deterioro.

c.- La cronicidad.

37.- A nivel músculo-esquelético, en la vejez se van a producir una serie de cambios. Entre ellos, podemos señalar:

a.- La reducción de la vascularización capilar.

b.- El aumento de la rigidez del colágeno de las articulaciones.

c.- La reducción de la sensibilidad de la pared torácica.

38.- A nivel funcional, los cambios en el sistema respiratorio, suponen:

a.- La disminución de la efectividad propulsiva de la tos.

b.- El incremento de las complicaciones mecánicas e infecciosas.

c.- Ambas opciones son correctas.

39.- Las enfermedades crónicas en la vejez se caracterizan por ser:

a.- Prolongadas, progresivas y habitualmente incurables.

b.- Prolongadas, acumulativas y habitualmente incurables.

c.- Prolongadas, progresivas y siempre incurables.

40.- La mayor parte de las enfermedades que afectan a los ancianos:

a.- Tienen una única causa externa identificable.

b.- No tienen una causa externa identificable.

c.- Suelen tener tratamientos eficaces a corto plazo.

41.- En la vejez se van a producir modificaciones en las funciones cognitivas. Entre ellas en las relacionadas con (señala la opción incorrecta):

a.- La personalidad.

b.- La creatividad.

c.- La resolución de problemas.

42.- En las capacidades intelectuales de las personas mayores, se va a producir:

a.- Una pérdida.

b.- Un deterioro.

c.- Un enlentecimiento.

43.- En las personas mayores será frecuente encontrar:

a.- Fatiga intelectual.

b.- Pérdida de atención y dificultades en la concentración.

c.- Ambas opciones son correctas.

44.- En los ancianos, en el plano de la inteligencia, encontramos una disminución:

a.- En la inteligencia fluida.

b.- En la inteligencia cristalizada.

c.- En ambas facetas.

45.- En la pérdida de la memoria reciente influyen:

a.- Factores físicos como los cambios neurológicos y circulatorios o en la oxigenación y nutrición celular.

b.- Factores psicológicos como la pérdida de motivación o la vivencia de los duelos.

c.- Ambas opciones son correctas.

46.- Entre las características de la "personalidad adaptada" en las personas mayores, podemos señalar:

a.- Ancianos que se mantienen activos e interesados por el entorno que les rodea.

b.- Ancianos pasivos, pero satisfechos con su jubilación.

c.- Ambas opciones son correctas.

47.- En relación al proceso de interioridad, en las personas mayores se generan dos procesos (señala la opción incorrecta):

a.- La disminución de la energía del yo.

b.- El predominio del estilo del dominio activo.

c.- El predominio del estilo del dominio pasivo.

48.- Para Erikson, en la vejez, la crisis de la personalidad debe resolver la tensión entre:

a.- Deterioro vs. Resistencia.

b.- Integridad vs. Desesperación.

c.- Normalidad vs. Diversidad.

49.- El envejecimiento se caracteriza por una mutua separación, por parte de la persona mayor, que va disminuyendo voluntariamente sus actividades y compromisos. Esta teoría se denomina:

a.- Teoría de la soledad.

b.- Teoría de la desvinculación.

c.- Teoría del aislamiento.

50.- Los cuadros psiquiátricos más frecuentes en la vejez, están relacionados con:

a.- Trastornos afectivos.

b.- Trastornos en el comportamiento.

c.- Trastornos relacionales.

51.- El trastorno afectivo más frecuente durante la vejez es:

a.- La depresión mayor.

b.- La depresión menor.

c.- El trastorno bipolar.

52.- Las demencias se generan en relación a:

a.- Enfermedades del cerebro.

b.- Enfermedades del sistema nervioso.

c.- Enfermedades vasculares.

53.- La denominada pseudodemencia viene causada por:

a.- Factores neurológicos.

b.- Factores psíquicos.

c.- Factores morfológicos.

54.- En el sueño de los ancianos es frecuente encontrarnos:

a.- Episodios de insomnio.

b.- Agitación psicomotriz.

c.- Ambas opciones son correctas.

55.- La geriatría, como área de conocimiento, se va a dedicar a estudiar:

a.- Las patologías asociadas a la vejez.

b.- La promoción de la salud.

c.- El rol activo de los mayores en la sociedad.

56.- La gerontología tiene como objetivo:

a.- La prolongación de la vida.

b.- La mejora de la calidad de vida.

c.- Ambas opciones son correctas.

57.- Lehr va a estudiar los estereotipos relacionados con la vejez. Uno de los siguientes no es correcto. Señala cuál:

a.- Los ancianos son muy diferentes entre sí.

b.- Las personas mayores son improductivas.

c.- Las personas mayores no son atractivas.

58.- Los programas de preparación para la jubilación deben contemplar:

a.- El conocimiento de las alteraciones y problemas de salud que se pueden presentar con la edad.

b.- La ocupación del tiempo libre.

c.- Ambas opciones son correctas.

59.- En relación a los tipos de personalidad que se adoptan tras la jubilación, si hablamos del "individuo enojado", estamos afirmando como característica que:

a.- Eluden sus responsabilidades.

b.- Necesitan estar siempre ocupados.

c.- Se consideran fracasados, el mundo tiene la culpa de todo.

60.- El termino edadismo fue acuñado en el año 1.969 por:

a.- Robert Butler.

b.- Walker y Avant.

c.- Castanedo y colaboradores.

61.- Como se denominan las actitudes, creencias, estereotipos o prácticas discriminatorias hacia las personas mayores:

a.- Geriatrismo.

b.- Edadismo.

c.- Mayorazgo.

62.- El concepto de envejecimiento activo se desarrolla en el contexto de las llamadas "teorías de la actividad":

a.- En los años 60.

b.- En los años 70.

c.- En los años 80.

63.- Según la definición clásica de la OMS el envejecimiento activo es el proceso de optimización de las oportunidades de:

a.- Salud, prevención y participación.

b.- Salud, participación y seguridad.

c.- Promoción, participación y corresponsabilidad.

64.- El Ayuntamiento de Madrid, como miembro de la Red Mundial de Ciudades Amigables con las personas mayores, ha desarrollado:

a.- El índice de feminización del envejecimiento.

b.- El índice de envejecimiento activo.

c.- El índice de sobreenvejecimiento.

65.- Para la construcción del paradigma del envejecimiento activo se utilizan una serie de indicadores, entre los que podemos encontrar:

a.- Empleo y participación social.

b.- Vida independiente y segura.

c.- Además de las anteriores, capacidad para un envejecimiento saludable.

66.- Desde una perspectiva cognitiva, la soledad no deseada es:

a.- La discrepancia entre las relaciones sociales que una persona desearía tener y las que realmente tiene.

b.- La discrepancia entre las relaciones sociales que el entorno entiende que una persona debe tener y las que realmente tiene.

c.- La discrepancia entre las relaciones sociales que los profesionales valora como necesarias y las que la persona desea tener.

67.- Las dimensiones de la soledad no deseada son:

a.- Dimensión personal, familiar y comunitaria.

b.- Dimensión íntima, dimensión relacional y dimensión colectiva.

c.- Dimensión afectiva, dimensión cognitiva y dimensión volitiva.

68.- El Ayuntamiento de Madrid aprueba la Estrategia Municipal contra la soledad emocional o relacional de las personas mayores dentro de los acuerdos planteados:

a.- En el Plan Estratégico de Servicios Sociales.

b.- En el nuevo modelo de Servicios Sociales planteado con la aprobación de la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

c.- En los Pactos de la Villa.

69.- La Estrategia Municipal contra la soledad emocional o relacional de las personas mayores se propone fortalecer la amigabilidad de la ciudad de Madrid mediante:

a.- La sensibilización a la ciudadanía y la detección de riesgos.

b.- La intervención sobre la soledad y sus consecuencias.

c.- Ambas opciones son correctas.

70.-Señala cual de los siguientes "pilares" no se contempla en la Estrategia Municipal contra la soledad emocional o relacional de las personas mayores:

a.- Madrid, amiga.

b.- Madrid, en red.

c.- Madrid, más cerca de ti.

71.- El pilar "Madrid en red" dentro de la Estrategia Municipal contra la soledad emocional o relacional de las personas mayores, se va a centrar en:

a.- El programa comunitario de potenciación de las redes sociales.

b.- El programa de acompañamiento (voluntariado).

c.- El programa de prevención universal, selectiva e indicada.

72.- El pilar "Madrid te acompaña" dentro de la Estrategia Municipal contra la soledad emocional o relacional de las personas mayores, se va a centrar en:

a.- El programa comunitario de potenciación de las redes sociales.

b.- El programa de acompañamiento (voluntariado).

c.- El programa de prevención universal, selectiva e indicada.

73.- El pilar "Madrid contigo" dentro de la Estrategia Municipal contra la soledad emocional o relacional de las personas mayores, se va a centrar en:

a.- El programa comunitario de potenciación de las redes sociales.

b.- El programa de acompañamiento (voluntariado).

c.- El programa de prevención universal, selectiva e indicada.

74.- La Estrategia Municipal contra la soledad emocional o relacional de las personas mayores plantea como innovaciones (señala la opción incorrecta):

a.- Los equipos de visitas domiciliarias.

b.- Las residencias municipales.

c.- Las actividades grupales preventivas para desarrollar en los centros municipales.

75.- El pilar "Madrid Contigo" de la Estrategia Municipal contra la soledad emocional o relacional de las personas mayores, se va a centrar en:

a.- La prevención primaria de la soledad no deseada.

b.- La prevención primaria y secundaria de la soledad no deseada.

c.- La prevención primaria, secundaria y terciaria de la soledad no deseada.

Plantilla de respuestas

1.-	B, p. 5	**6.-**	C, p. 3	**11.-**	A, p. 7
2.-	B	**7.-**	C	**12.-**	C, p. 7
3.-	A, p. 3	**8.-**	A	**13.-**	B, p. 7
4.-	C	**9.-**	B	**14.-**	C, p. 7
5.-	B, p. 5	**10.-**	A, p. 5	**15.-**	C, p. 8

16.-	A, p. 8	**21.-**	A, p. 9 ss	**26.-**	C, p, 14
17.-	B, p. 9	**22.-**	A, p. 10	**27.-**	C, p. 14
18.-	A, p. 8	**23.-**	B, p. 10	**28.-**	C, p. 14
19.-	B, p. 8	**24.-**	C, p. 10	**29.-**	A, p. 14
20.-	C, p. 8	**25.-**	C, p. 12	**30.-**	A, p. 11

31.-	B, p. 9	**36.-**	A, p. 16	**41.-**	A, p. 20
32.-	A, p. 8	**37.-**	B, p. 16	**42.-**	C, p. 19
33.-	A, p. 5	**38.-**	C, p. 17	**43.-**	C, p. 19
34.-	C, p. 5	**39.-**	A, p. 18	**44.-**	A, p. 19
35.-	B, p. 15	**40.-**	B, p. 18	**45.-**	C, p. 19

46.-	C, p. 20	**51.-**	B, p. 22	**56.-**	C, p. 26
47.-	B, p. 21	**52.-**	A, p. 23	**57.-**	A, p. 27
48.-	B, p. 21	**53.-**	B, p. 24	**58.-**	C, p. 30
49.-	B, p. 21	**54.-**	C, p. 25	**59.-**	C, p. 31
50.-	A, p. 22	**55.-**	A, p. 26	**60.-**	A, p. 33

61.-	B, p. 33	**66.-**	A, p. 39	**71.-**	A, p. 42
62.-	A, p. 34	**67.-**	B, p. 39	**72.-**	B, p. 42
63.-	B, p. 34	**68.-**	C, p. 40	**73.-**	C, p. 42
64.-	B, p. 38	**69.-**	C, p. 40	**74.-**	B, p. 43
65.-	C, p. 38	**70.-**	A, p. 42	**75.-**	C, p. 41